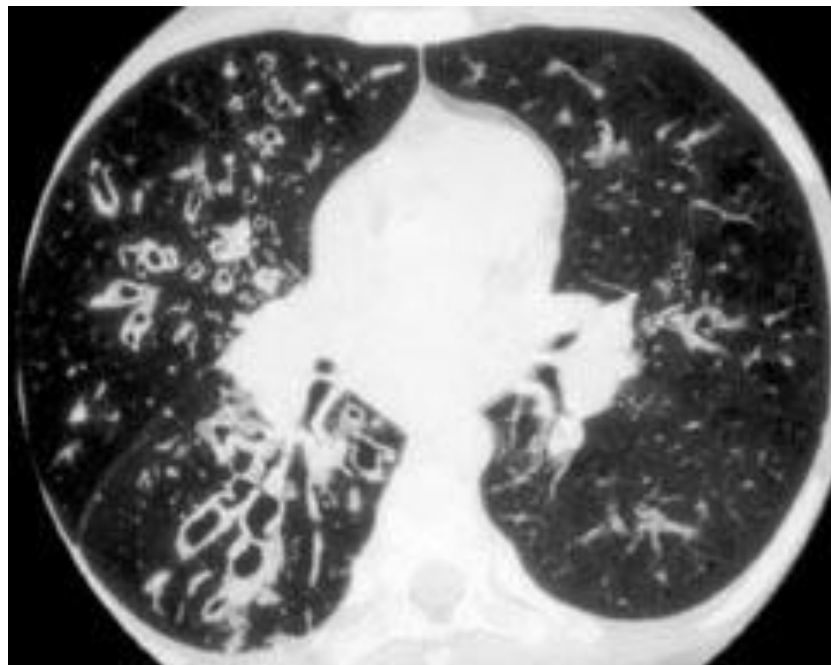


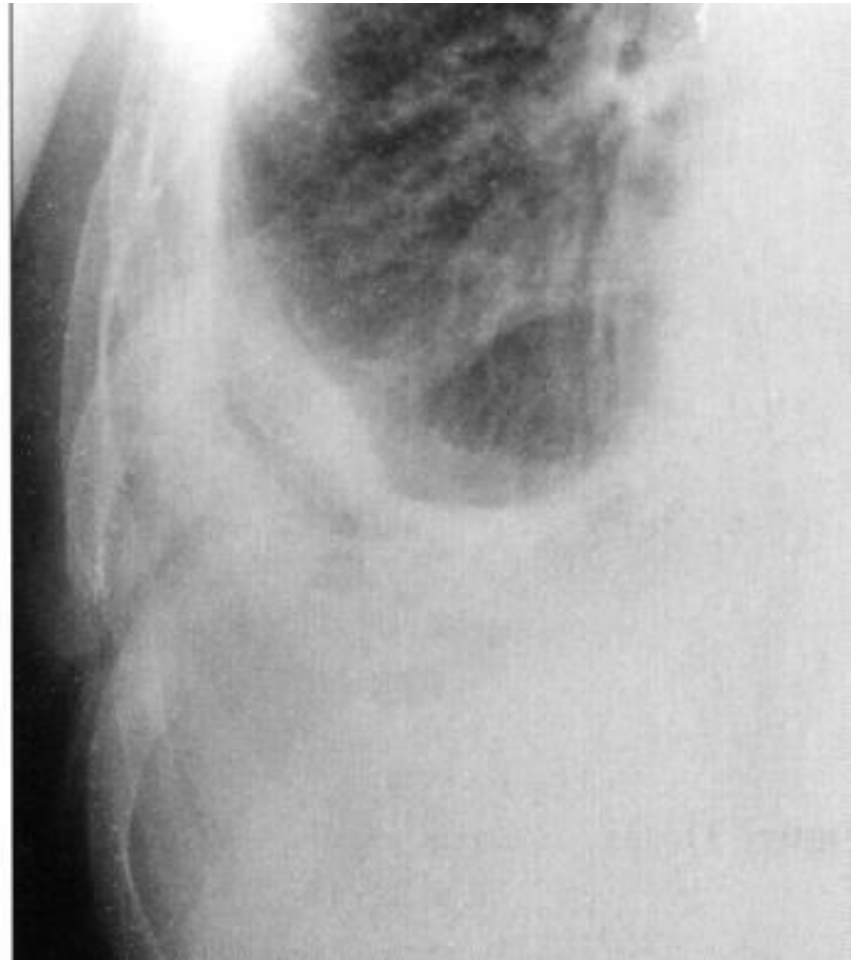
КТ на гръдна клетка. Патологичните промени на белия дроб представляват:



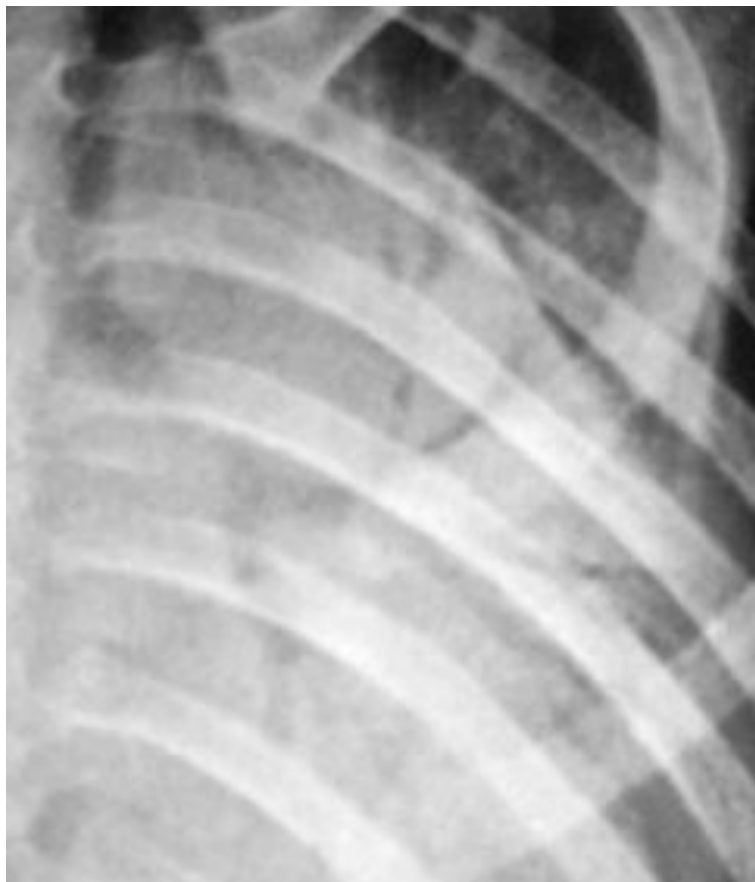
1. Дилатация на бронхи
2. Кавитации в паренхима
3. Дилатация на кръвоносни съдове

2. Прицелна графия на дясна белодробна основа. Засенчването в КДС най-вероятно се дължи на:

1. Срастване
2. Емпием
3. Серозен излив



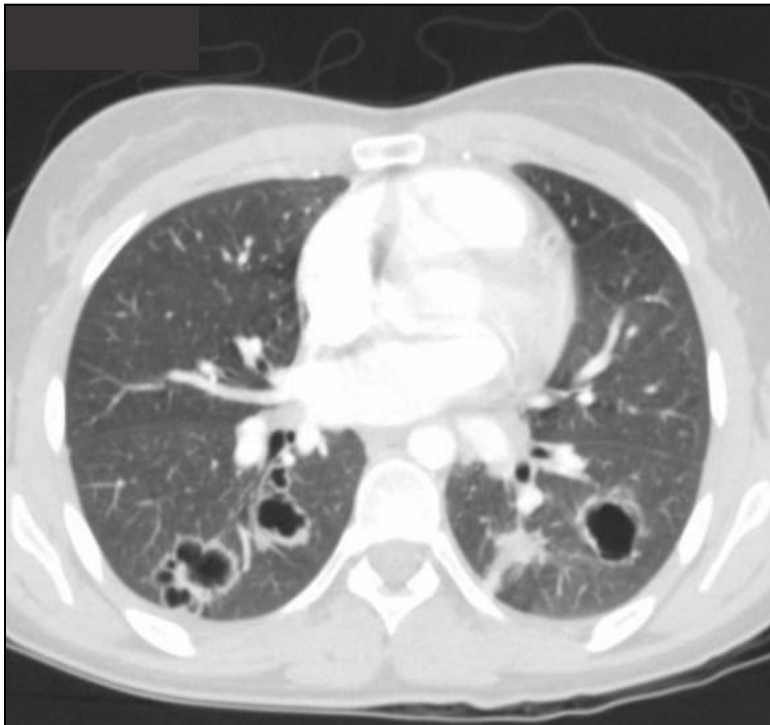
5. Слабите сенки се дължат на:



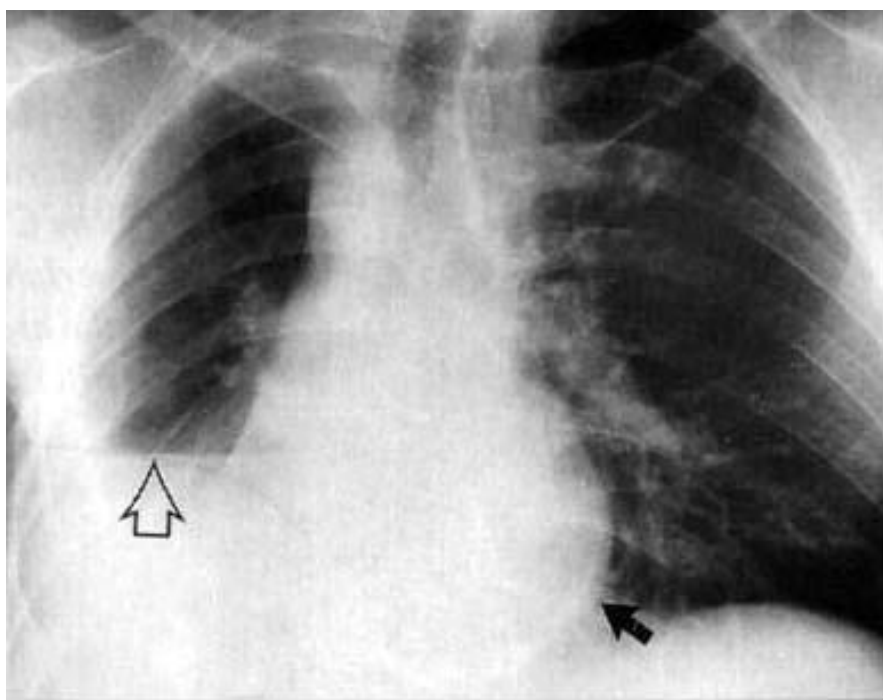
1. Разпад в инфилтрат
2. Интерстициален едем
3. Въздушна
бронхограма

Огнищните лезии в белия дроб при тази
млада жена са:

1. **Кавитации**
2. Възпалителни инфилтрати
3. Паренхимни формации

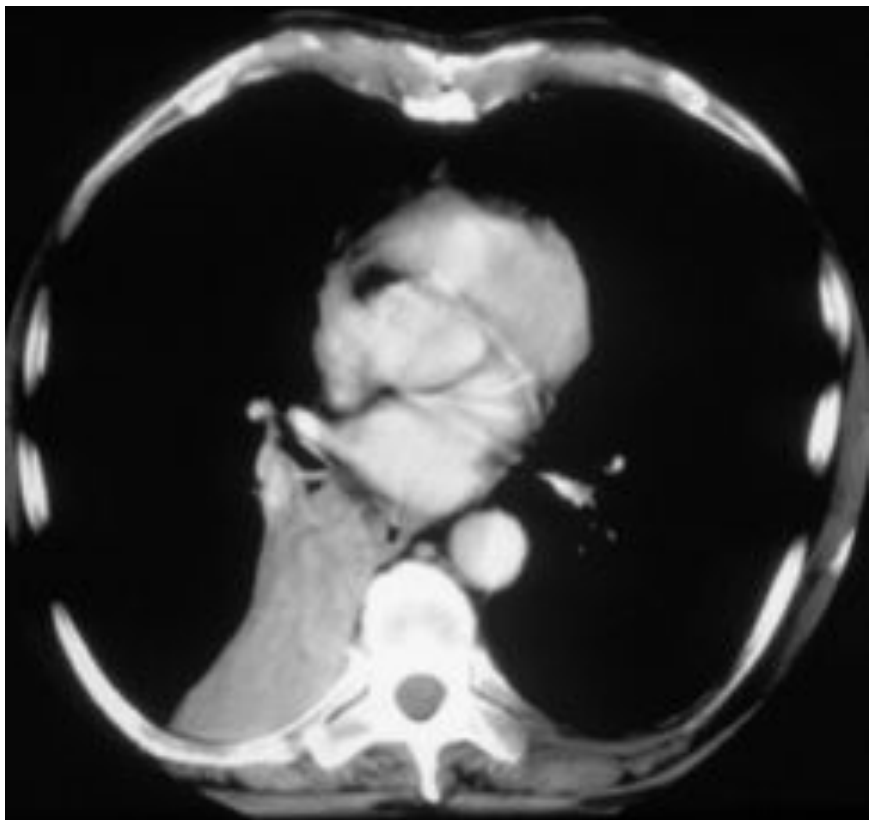


Посоченото с бялата стрелка засенчване в дясната основа се дължи на:



1. Диафрагмална херния
2. Хидропневмоторакс
3. Хидроторакс

На кой дял е ателектазата:



1. Долен десен

2. Горен десен

3. Среден десен

**Двустранното ангажиране на върховете на
белия дроб най-вероятно се дължи на**



1. Карциноматоза
2. Венозен застой
при митрална
стеноза
3. **Туберкулоза**

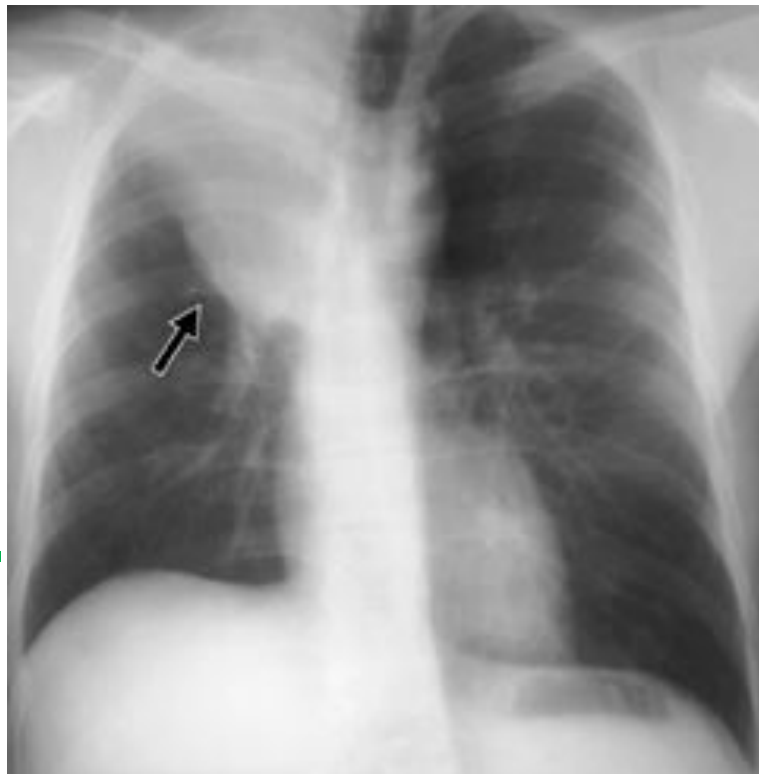
Рентгеновата находка се причинява от една от следните причини:

1. Съдова
медиастинална
2. Туморна
екстраме-
диастинална
3. Туморна
медиастинална

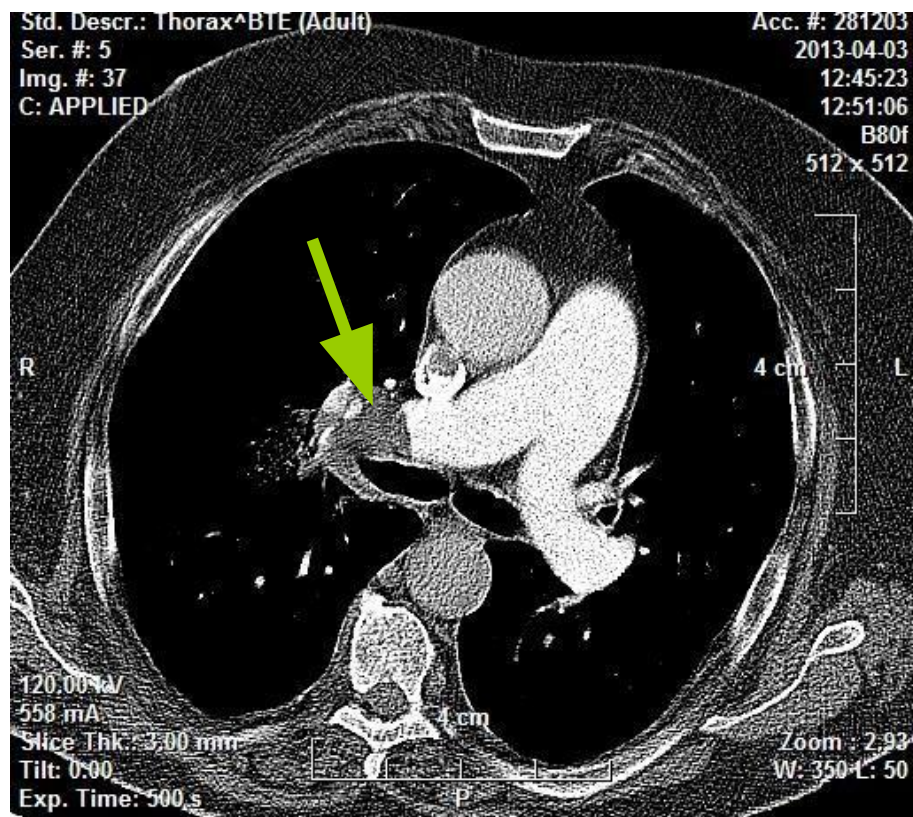


Патологичната сянка е с характерна картина
на:

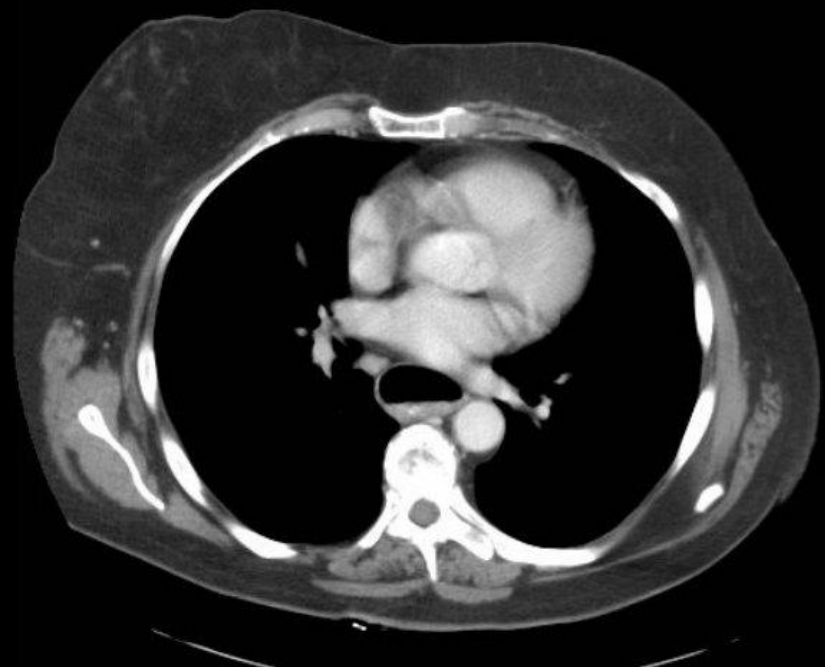
1. Пневмония
2. Капсулиран
плеврален излив
3. Ателектаза на
горния дял



4. Патологичният процес, посочен със стрелка е:



1. Белодробна тромбоемболия
2. Карцином в десния хилус
3. Чуждо тяло в бронха



Абнормалността е в:

1. аортата
2. хранопровода
3. трахеята

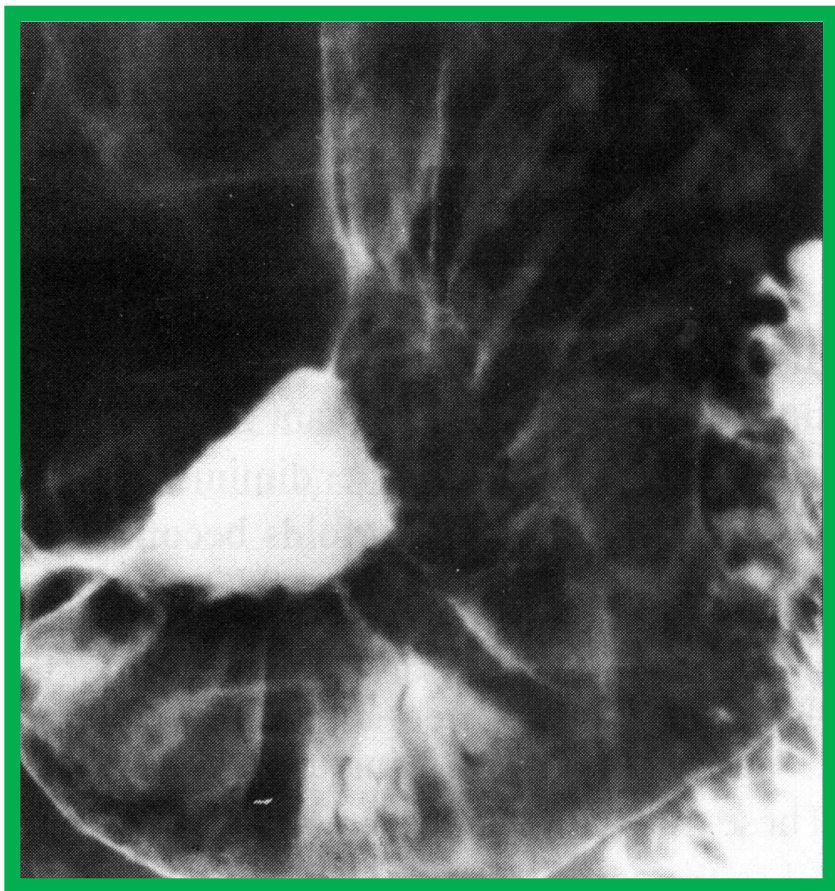
Патологичните находки на обзорната рентгенография на корема са:

1. Калцификати - невробластома

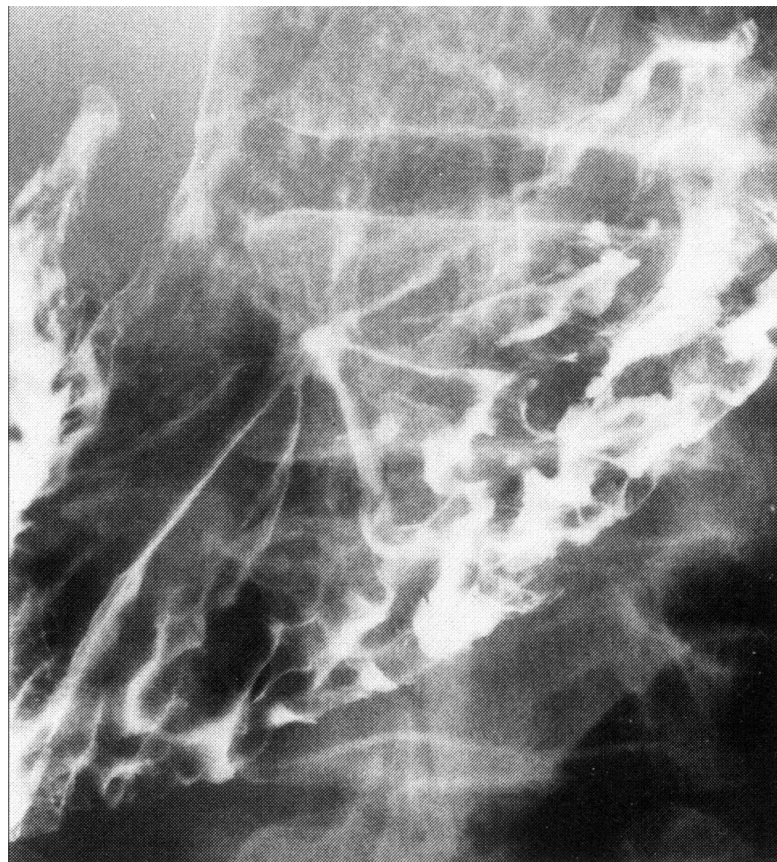
2. Хидроаерични колекции
3. Костни аномали



7. Малигнената язва е под номер:



1



2

1. Находката от абдоминалната рентгенография на новородено се дължи на:

1. Инвагинация

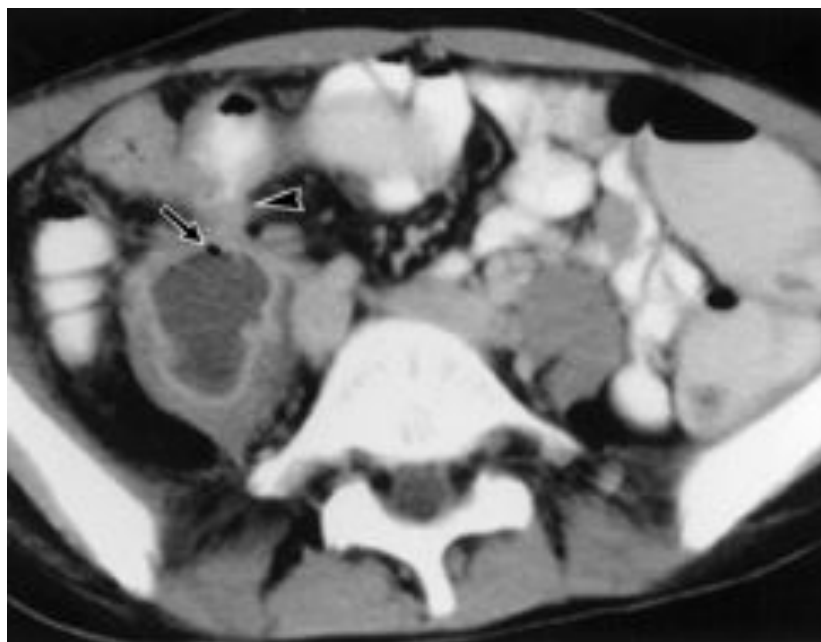
2. Асцит

3. Илеус

4. Перфорация



8. Болестта на Крон е усложнена с абсцес в:



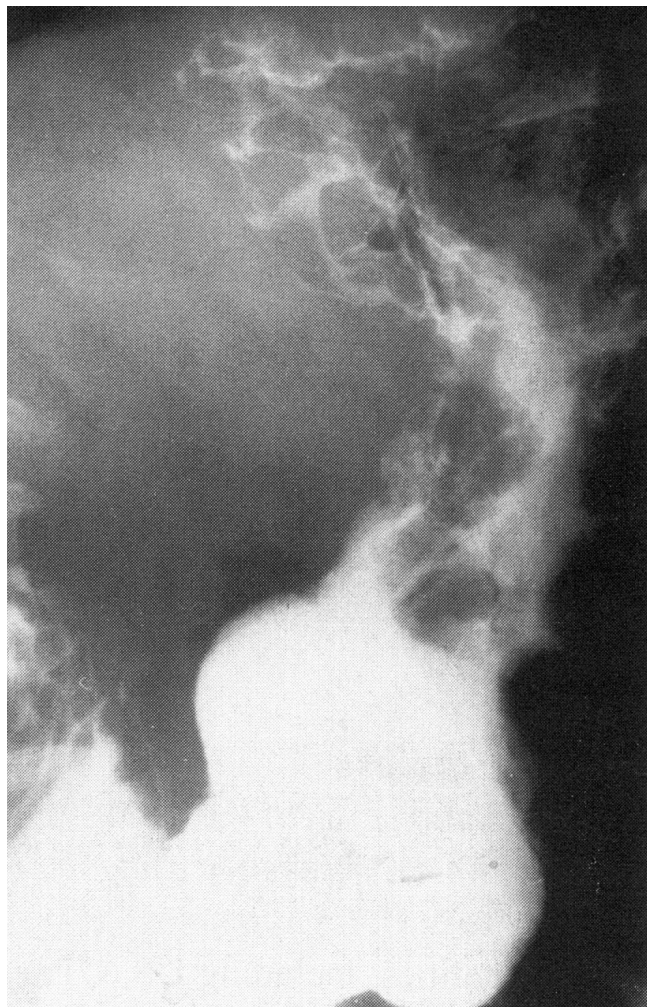
1. Мезоколона
2. Бъбречната капсула
3. М. псоас

Посочете верния отговор:



1. Улцерозен колит
2. Болест на Крон
3. Илеус

Промените в стомаха са:



1. **Добавни сенки**
2. **Дилатация на кух орган**
3. **Дефекти в изпълването**

На микционната цистография патологичен е:



- 1.
- 2.
- 3.

Левият уретер

Десният уретер

Пикочният мехур

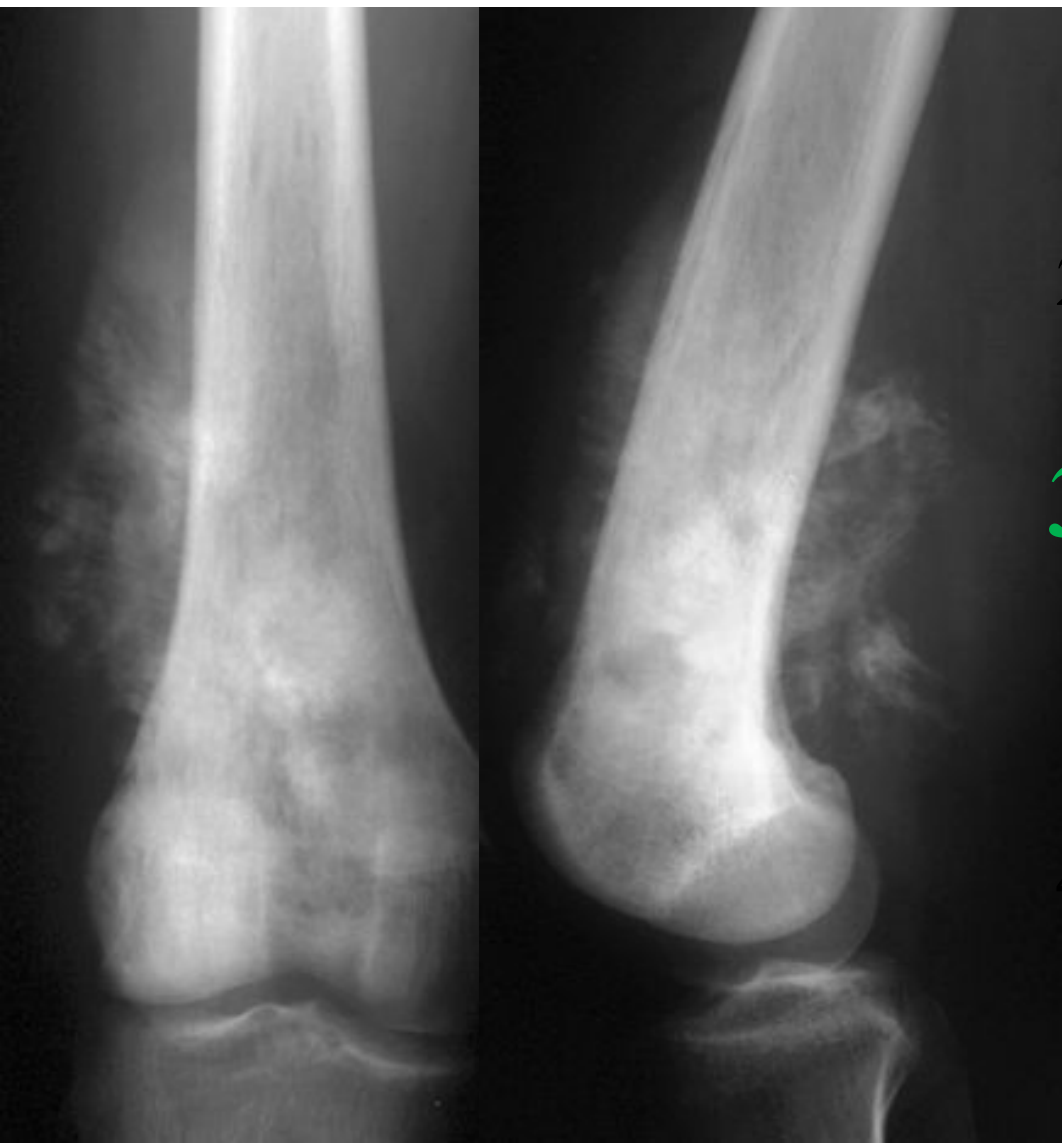
Микционна
цистография

Може ли находката от КТ да се определи като адултна форма на поликистоза?



1. Да
2. Не

6. Представената спикурообразна периостална реакция е типична за:

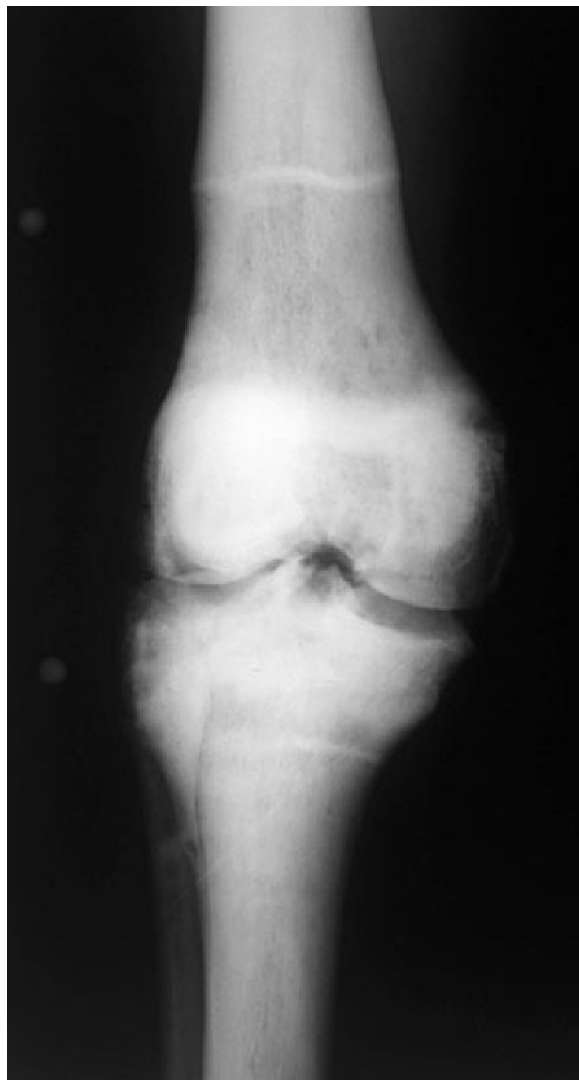


1. Остеомиелит
2. Травматичен
периостит

3. Малигнен
тумор на
костта

4. Метастаза

Кой основен патологичен процес се наблюдава в костите, изграждащи колянната става:



1. Остеопороза
2. Остеосклероза
3. Остеолиза
4. Остеодистрофия
5. Периостална реакция.



Една от тарзалните кости е променена поради асептична некроза. Коя е тя?

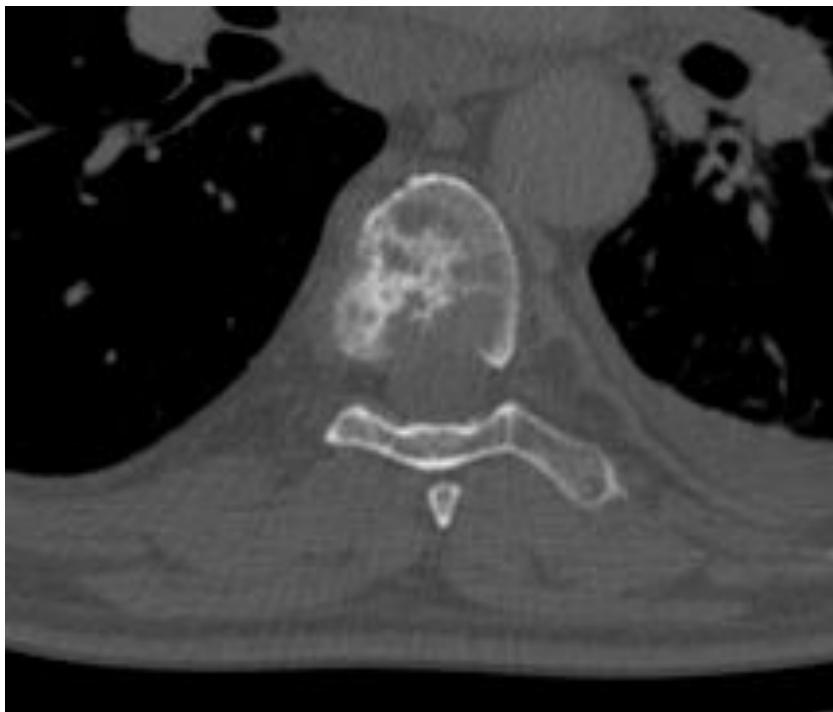
1. Os cuboideum
2. Os naviculare – болест на Кьолер I
3. Os cunieforme

Начинът на засягане на интерфалангеалните стави
е както при:



1. Остеоартрит
2. Ревматоиден
артрит
3. Остеомиелит

8. Метастазата в прешлен от бронхогенен карцином е:



1. **Остеосклеротична**
2. **Остеолитична**
3. **Смесена**

В костите на таза се наблюдава:

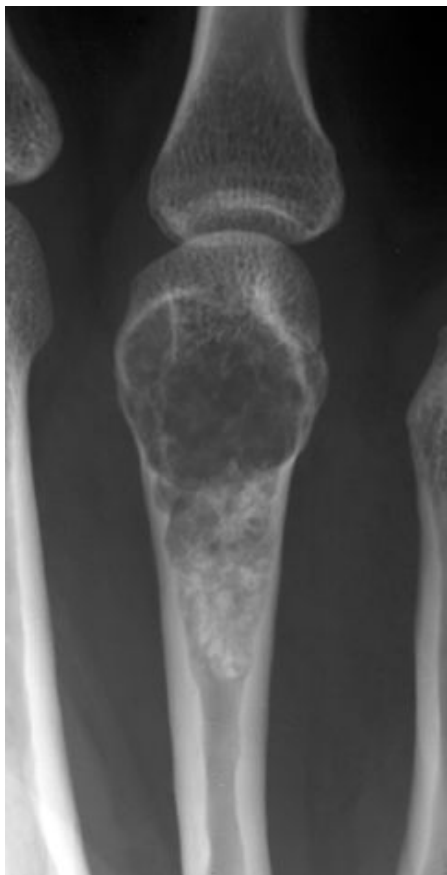
1. Петниста остеопороза

2. **Петниста остеосклероза -
остеопойкилоза**

3. Петниста остеолиза



Костната лезия се дължи на:



1. Костна киста
2. Енхондром
3. Метастаза

Образът е характерен за:



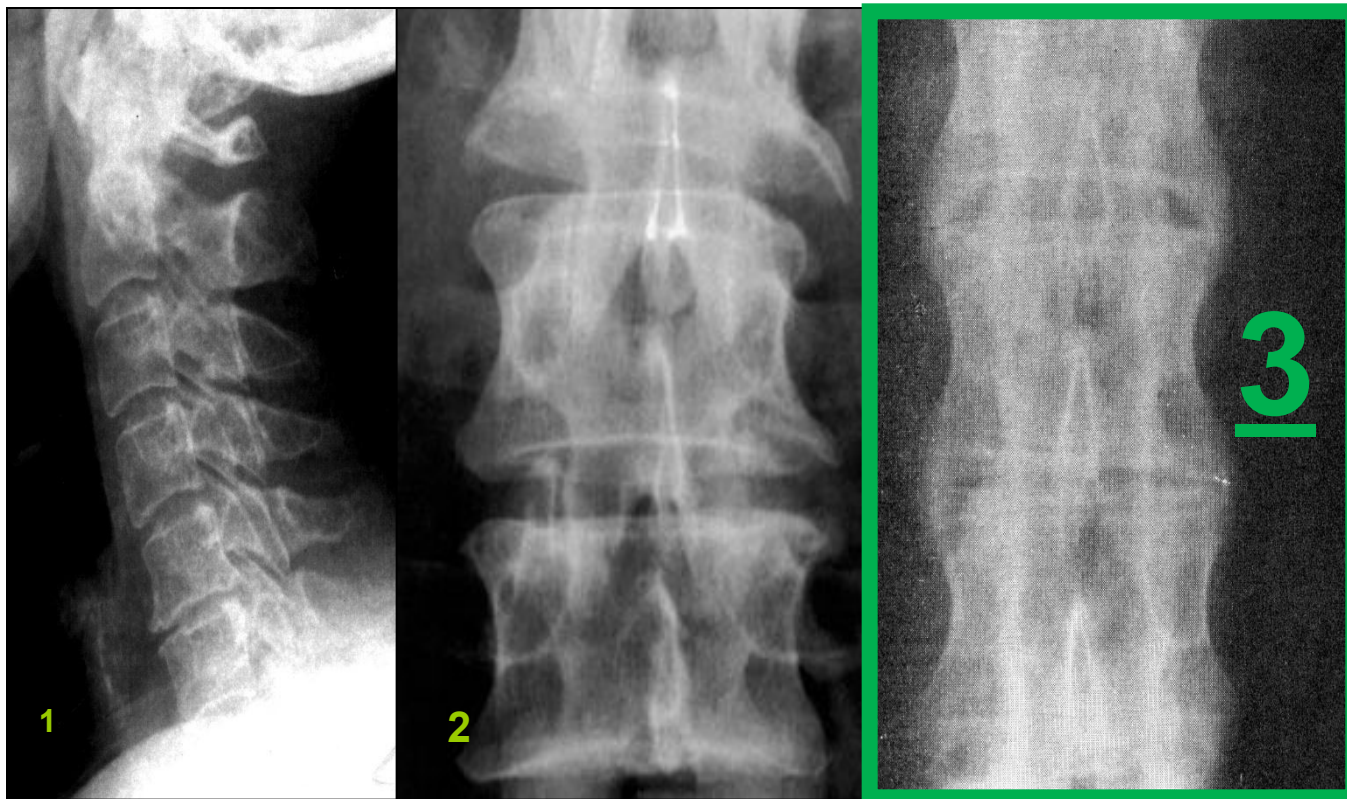
1. Остеом
2. Миелом
3. Ангиолипом
4. Хордом

Това е болест на:

1. Клатцкин
2. Крукенберг
3. **Кьолер** – *тип II*
(Фрайберг) – на главичката на метафизарната кост, най-често на II метафизарна кост. Най-честа при девоите!!!
4. Курваозие
5. Кинбьок
6. Кароли
7. Капоши



**На коя от графите на гръбначен
стълб има болест на Бехтерев**



Начинът на засягане на интерфалангеалните стави е както при:



1. Остеоартрит
2. Ревматоиден артрит
3. Подагра

Субдуралният хематом е:



1. Остър

2. Подостър

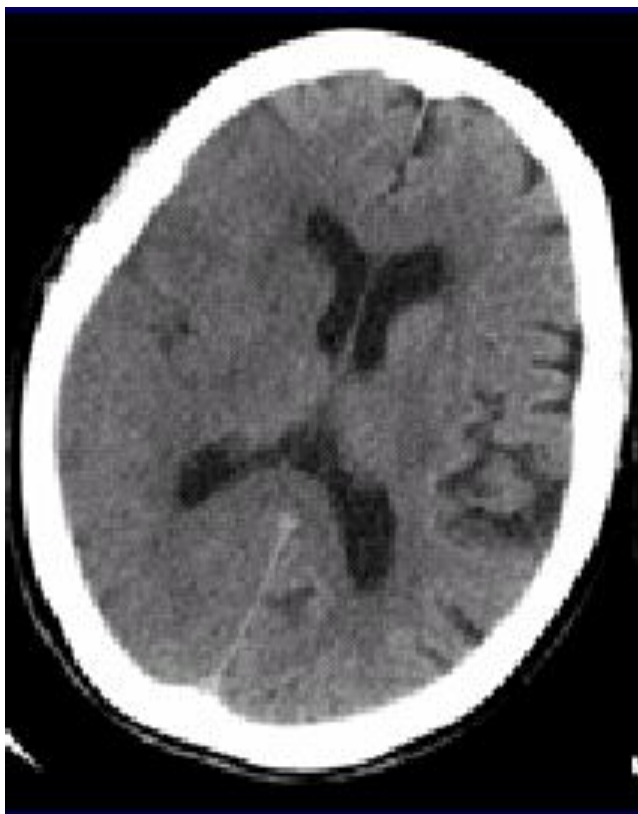
3. Хроничен

В какъв стадий е субдуралният хематом?

1. Остър
2. Подостър
3. Хроничен



2. Ишемичният инсулт в остър стадий е разположен в:

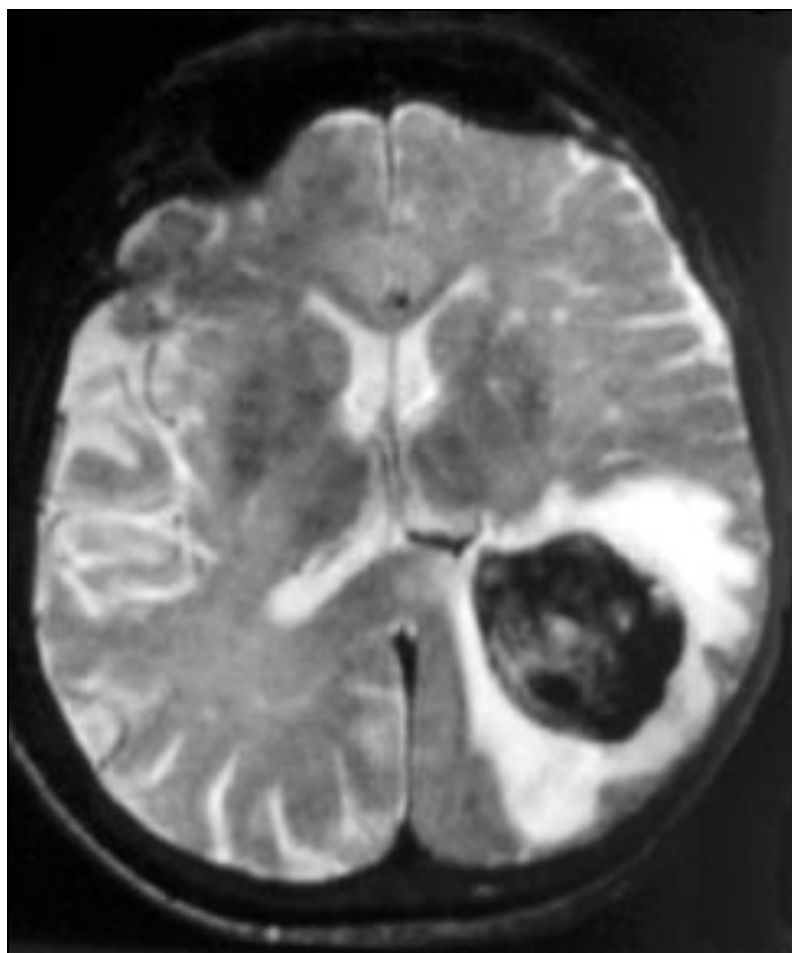


1-Вдясно

2-Вляво

Стадиите на исхемията са: 1. Свръхакутен –до 6 час, 2. Акутен – 6-12 ч, 3. Субакутен над 12 ч и т.н.

4. Патологичната лезия е разположена:



1. **Инфратенториално**
2. **Екстрааксиално**
3. **Интравентрикуларно**
4. **Интрааксиално**

Патологичната лезия в гръбначномозъчния канал е разположена:

1. Интрамедуларно
2. Екстрамедуларно интрадурално
3. Екстрадурално



Обзорна графия на корема с предно-задна
посока на лъча. В какво положение е
болния:

1. **Легнало**
2. **Изправено**
3. **Легнал странично**

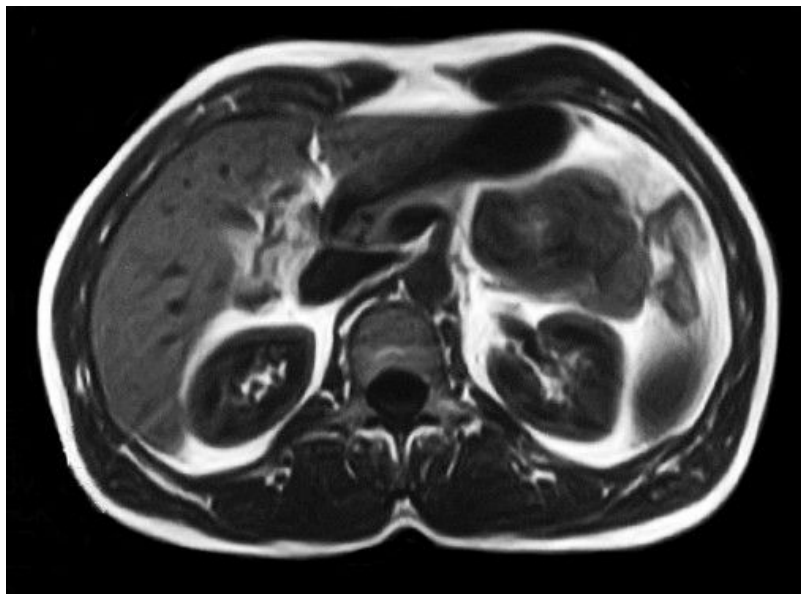


6. Рентгенографията на корема на новородено е:



1. Абнормна по причина на белия дроб и сърцето
2. Абнормна по причина на корема
3. Абнормна по причина на костите

Този транзверзален срез е получен чрез:



1. Компютърна томография
2. Компютърна томография с контрастно усилване
3. Конвенционална томография
4. Магнитно резонансна томография – черни кости

1. Трикуспидалната клапа се разполага :

1. Между ляво предсърдие и лява камера
2. Между дясно предсърдие и дясна камера
3. Между лява камера и аорта
4. Между дясна камера и белодробна артерия

2. Торакалните прешлени се разполагат:

1. Каудално от лумбалните
2. Краниално от цервикалните

3. Каудално от цервикалните

3. Белодробната тромбоемболия представлява:

- 1. Тромбоза на белодробните вени**
- 2. Тромбоза на белодробните
артерии**
- 3. Тромбоза на бронхите**

4. Епифизите са елементи на:

1. Дългите кости

2. Плоските кости

3. Носните кости

5. Тимусната жлеза се разполага:

1. Ретросакрално
2. Ретрокавално
3. Ретроаурикуларно
4. Ретростернално
5. Ретробулбарно

1. Малкият кръг на кръвообращението включва следните последователно разположени анатомични структури:

1. Дясно предсърдие -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие
2. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> ляво предсърдие
3. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> лява камера
4. Дясна камера -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие

2. Кистите (на различни органи) на компютъртомографския образ най-често са:

1. Хиподенсни

2. Хиперденсни

3. Изоденсни

5. Бъбречните калици съдържат нормално:

1. Вторична урина

2. Венозна кръв

3. Първична урина

4. Артериална кръв

4. Дилатирани чревни бримки се срещат при:

1. Илеус

2. Малигнен асцит

3. Тромбоза на порталната вена

4. Болест на Крон